



Malang, 13 Februari 2026

Nomor : 129.12/I-UND/IGZ/II/2026
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Terlampir

Dengan hormat,
Diharap untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 14 Februari 2026
Acara : Rapat Asuhan Gizi Tentang Kriteria Risiko Nutrisional
Pukul : 18.00 WIB – Selesai
Tempat : Lantai IRNA 3A

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka diharapkan **wajib hadir**. Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat,
Kepala Instalasi Gizi
Rumah Sakit Prima Husada

Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz

Lampiran : 1 Halaman
Nomor : 129.12/I-UND/IGZ/II/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA UNDANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Chandrawati Mustikasari, S.Tr.Gz	Ahli Gizi
2	Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz	Ahli Gizi
3	Nafisah Ulfa H., S.Gz	Ahli Gizi
4	Very Susanto S. Kep. Ns	Perawat
5	Wiwit Indah	Perawat

Hormat,
Kepala Instalasi Gizi
Rumah Sakit Prima Husada



Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Sabtu, 14 Februari 2026
 PUKUL : 09.00-selesai
 AGENDA RAPAT : Asuhan Gizi tentang Kriteria Risiko
 Nutrisional
 Berikut hasil notulen :

PEMIMPIN RAPAT : Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz
 NOTULIS : Nafisah Ulfa H, S.Tr.Gz
 TEMPAT : Lantai IRNA 3A

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Pasien dikategorikan berisiko nutrisi apabila memiliki satu atau lebih kondisi berikut: 1) Penurunan berat badan signifikan 2) Indeks Massa Tubuh (IMT) < 18,5 kg/m² atau > 25 kg/m² dengan komplikasi 3) Asupan makan menurun $\geq$ 50% dari kebutuhan selama $\geq$ 3 hari 4) Diagnosis penyakit dengan risiko malnutrisi tinggi. 5) Gangguan menelan atau gangguan gastrointestinal 6) Pasien geriatri, pediatri risiko tinggi, atau pasien kritis Kriteria akan disesuaikan dengan instrumen skrining yang disepakati (MST).	Perlu ada pengawasan kepatuhan dalam pengisian skrining awal gizi saat pasien datang di IGD	Pengecekan kelengkapan dalam pengisian skrining awal gizi	Perawat
2.	1. Skrining nutrisi dilakukan oleh perawat dalam waktu $\leq$ 24 jam sejak pasien masuk. 2. Pasien dengan hasil skrining berisiko akan dirujuk ke ahli gizi. 3. Asesmen gizi lengkap dilakukan maksimal 1x24 jam setelah hasil skrining risiko diketahui.	-	Perlu pengawasan dan mempertahankan alur yang sudah benar	1. Perawat: Melakukan skrining awal risiko nutrisi. 2. Ahli Gizi: Melakukan asesmen, diagnosis gizi, intervensi, monitoring dan evaluasi. 3. Dokter Penanggung Jawab: Kolaborasi dalam

	4. Intervensi dan monitoring didokumentasikan dalam rekam medis terintegrasi.			perencanaan terapi medis dan diet. 4. Kepala Instalasi Gizi: Monitoring implementasi panduan. 5. Komite Mutu: Evaluasi kepatuhan dan indikator mutu.
--	---	--	--	---

Pemimpin Rapat
Kepala Instalasi Gizi



(Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz)

Malang, 13 Februari 2026
Notulis



(Nafisah Ulfa Hasanah, S. Gz)

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

DOKUMENTASI

NB : Lampirkan minimal 2 foto





ABSENSI RAPAT 2026

No	Nama	TTD
1.	Very Susanto S.kep-Ns	
2.	Wiwit Irtan cs.	
3.	Chandrawati Mushikasari	
4.	Nafisah Ulea	
5.	Alfira C-	
6.		
7.		
8.		
9.		